

LUCIMARA RAMOS			
MEDICAMENTOS:			
SINTOMAS/QUEIXAS		Sonolência / cansaço	
BANHEIRO			
HORA QUE ACORDA		07	IAH = 41.6 e/ev
HORA QUE DORME		23	
PRÁTICA EXERCÍCIO			
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES			
CAFE:	ALMOÇO:	LANCHE:	JANTA:
26/05 P = 6,4 cmH₂O IAH = 0,3 22 M. de uso: 7h 41' Bem adaptada, sem queixas <i>fua</i> 28/06 P = 6,4 IAH = 0,7 22 M. de uso: 7h 40' Bem adaptada, relata melhora do memória/foco <i>fua</i> SONO (0-10) NOTA → 9 28/07 P = 6,4 cmH₂O IAH = 0,4 e/ev 22 M. de uso: 7h 10' <i>fua</i> 08/09 P = 6,4 cmH₂O IAH = 0,3 e/ev 22 M. de uso: 7h 31' <i>fua</i> 03/11 P = 6,4 cmH₂O IAH = 0,3 e/ev 22 M. de uso: 7h 31' <i>fua</i> 14/12 P = 6,4 cmH₂O IAH = 0,4 e/ev 22 M. de uso: 7h 15' Bem adaptada <i>fua</i> 16/02 P = 6,4 cmH₂O IAH = 0,4 e/ev 23 M. de uso: 7h 9' Fuga = 1,2. Relata que o cabelo está c/ dif. p/ ajustar <i>fua</i> 20/04 P = 6,4 cmH₂O IAH = 0,3 e/ev 23 M. de uso: 7h 12' Bem adaptada, exerc. físico <i>fua</i>			

29/06 $P = 6.4 \text{ cmH}_2\text{O}$
23 $\text{IAH} = 0.4 \text{ e/ev}$
m. de uso: 7h 10'
Fuga = 1.6 e/min.

31/08 $P = 6.4 \text{ cmH}_2\text{O}$ ($\downarrow 5.0 \text{ cmH}_2\text{O}$)
23 $\text{IAH} = 0.5 \text{ e/ev}$
m. de uso: 7hr

04/10 $P = 5.0 \text{ cmH}_2\text{O}$
23 $\text{IAH} = 1.1 \text{ e/ev}$
m. de uso: 6hr

09/02 $P = 5.4 \text{ cmH}_2\text{O}$
24 $\text{IAH} = 1.0 \text{ e/ev}$
m. de uso: 7:00 hrs

11/03 $P = 5.4 \text{ cmH}_2\text{O}$
24 $\text{IAH} = 0.4 \text{ e/ev}$
m. de uso: 6h 50'
Fuga = 0.0 e/pm.

20/05 $P = 5.4 \text{ cmH}_2\text{O}$
24 $\text{IAH} = 0.4 \text{ e/ev}$
m. de uso: 6hr

31/07 $P = 5.4 \text{ cmH}_2\text{O}$
24 m. de uso: 6h 30'
 $\text{IAH} = 0.6 \text{ e/ev}$ fua

07/10 $P = 5.4 \text{ cmH}_2\text{O}$
24 $\text{IAH} = 0.5 \text{ e/ev}$
m. de uso: 6h 48

Bem adaptada, deixou alguns dias s/ uso - fua

19/02 $P = 5.4 \text{ cmH}_2\text{O}$
24 $\text{IAH} = 0.7 \text{ e/ev}$
m. de uso: 5h 34'

Bem adapt.

fua cláudio

22/02 $P = 5.4 \text{ cmH}_2\text{O}$
25 $\text{IAH} = 0.8 \text{ e/ev}$
m. de uso: 6hr
fuga = 0.0 e/pm.

fua cláudio

14/05 $P = 5.4 \text{ cmH}_2\text{O}$
25 $\text{IAH} = 0.6 \text{ e/ev}$
m. de uso: 6h 27'
fuga = 6h 14'

Bem adapt.

clínica

DR. ALBERTO REMESAR
TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO
PSIQUIATRIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Especialista em Medicina do Sono
Sociedade Brasileira de Sono
Médico em Clínica de Sono
CRM-SP: 69.730

Dra. ELITÂNIA MARINHO PONTES
Medicina do Sono
CRM-SP: 62.858

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Lucimara Ramos

EXAME nº: 5059-2 CPAP

SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez

DATA: 13/04/2022

IDADE: 55 anos

Comentários:

Exame iniciado às 23h33min e concluído às 06h12min. A latência para o sono foi de 25 minutos e a latência para o sono REM, de 146 minutos. O tempo total de sono foi de 182 minutos (03h02min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 47,7%. A distribuição do sono mostrou 29,1% de estágio 1, 17,9% de estágio 2, 44,2% de estágio 3 e 8,8% de sono REM. No período total de sono permaneceu 174,5 minutos em vigília, ocorreram 94 microdespertares (índice: 31/hora).

O índice de movimentos dos membros inferiores foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 8,9/hora, sendo 0 apneia/hora e 8,9 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 8,9/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 95%, sendo a média de 93% e a mínima de 82%.

(*) TTS → Tempo Total de Sono TTR → Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

A paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ela usou a máscara oronasal ou facial Mirage Quattro medium (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 6,4 cm de H₂O.

Registraram-se aumentos leves dos índices de apneia/hipopneia (8,9/hora; índice leve: 5 a 15/hora) e de distúrbio respiratório (8,9/hora), ritmo cardíaco sinusal, despertares e episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina. As frequências cardíacas foram: mínima: 74; máxima: 100 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

A paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 25 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (146 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 47,7%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 31/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (29,1%; normal: 8-10%) e 3 (44,2%; normal: 10-12%), e a redução dos estágios 2 (17,9%; normal: 45-55%) e REM (8,8%; normal: 20%).

Sem movimentos periódicos de membros.

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
CRM-SP: 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Lucimara Ramos

EXAME nº: 5059

SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez

DATA: 17/02/2022

IDADE: 55 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h57min e concluído às 06h02min. A latência para o sono foi de 11 minutos e a latência para o sono REM, de 87 minutos. O tempo total de sono foi de 316 minutos (05h16min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 75,1%. A distribuição do sono mostrou 16,3% de estágio 1, 27,4% de estágio 2, 42,7% de estágio 3 e 13,6% de sono REM. No período total de sono permaneceu 93,5 minutos em vigília, ocorreram 118 microdespertares (índice: 22,4/hora).

O índice de movimentos dos membros inferiores foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 84,3/hora, sendo 41,6 apneia/hora e 42,7 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 84,3/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 94%, sendo a média de 92% e a mínima de 81%.

(*) TTS → Tempo Total de Sono TTR → Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (84,3/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (84,3/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, ritmo cardíaco sinusal e despertares. As frequências cardíacas foram: mínima: 68; máxima: 100 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de médio a alto.
Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

A paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 11 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava normal (87 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 75,1%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 22,4/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (16,3%; normal: 8-10%) e 3 (42,7%; normal: 10-12%), e a redução dos estágios 2 (42,7%; normal: 45-55%) e REM (13,6%; normal: 20%).

Sem movimentos periódicos de membros.
Escala de Sonolência de Epworth: 10 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM-SP: 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP: 69.730

www.clinicaalbertoremesar.com.br

INDICADO POR: Dr. André Costa
☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS 77 272362 000 100

clínica
DR. ALBERTO REMESAR
PSIQUIATRIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
CRM-SP 69730

DR. ELITÂNIA MARINHO PONTES
CRM-SP 62858

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Lucimara Ramos

EXAME nº: 5059-3

SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez

DATA: 29/11/2023

IDADE: 56 anos

Comentários:

Exame iniciado às 23h37min e concluído às 06h27min. A latência para o sono foi de 15 minutos e a latência para o sono REM, de 103 minutos. O tempo total de sono foi de 343 minutos (05h43min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 83,7%. A distribuição do sono mostrou 10,6% de estágio 1, 48,3% de estágio 2, 31,3% de estágio 3 e 9,8% de sono REM. No período total de sono permaneceu 51,5 minutos em vigília, ocorreram 63 microdespertares (índice: 11/hora).

O índice de movimentos dos membros inferiores foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 47,5/hora, sendo 2,6 apneia/hora e 44,9 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 64,5/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 94%, sendo a média de 93% e a mínima de 83%.

(*) TTS⇒ Tempo Total de Sono

TTR⇒ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (47,5/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (64,5/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 65; máxima: 81 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de médio a alto.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

A paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 15 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava normal (103 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 83,7%; normal: 85% ou acima), mas o índice de microdespertares (11/hora; normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (10,6%; normal: 8-10%) e 3 (31,3%; normal: 10-12%), e a redução do estágio REM (9,8%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 2 (48,3%; normal: 45-55%) permaneceu nos limites da normalidade. *Presença de padrões alternantes cíclicos (PAC)*

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 7 (normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730